

CALIDAD DE VIDA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (ADRQL)

Alzheimer's Disease-Related Quality of Life — Cuestionario para el Cuidador Principal
Rabins, Kasper, Kleinman, Black & Patrick (1999) • Adaptación española: Carnero et al.

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:
El cuidador principal indica si cada una de las siguientes afirmaciones describe la conducta y estado del paciente en las últimas 2 semanas, marcando de acuerdo (SÍ) o en desacuerdo (NO):
SÍ = De acuerdo (describe al paciente en las últimas 2 semanas) | **NO** = En desacuerdo

Nº	Conducta o Estado del Paciente Observado por el Cuidador	SÍ	NO
1	Él/ella sonríe o se ríe cuando está alrededor de otras personas		
2	Él/ella <i>no</i> pone atención a la presencia de otros		
3	Él/ella podría estar alrededor de otras personas		
4	Él/ella busca el contacto con otros saludando a las personas o uniéndose a las conversaciones		
5	Él/ella habla con las personas		
6	Él/ella toca o permite que le toquen como dar la mano, abrazar, besar o dar palmadas		
7	Él/ella puede ser confortado o tranquilizado por otros		
8	Él/ella <i>no</i> está a gusto con extraños o personas que no reconoce		
9	Él/ella reacciona con placer ante las mascotas o los niños pequeños		
10	Él/ella habla por teléfono con la gente		
11	Él/ella se molesta o se enfada cuando se acerca otra persona		
12	Él/ella empuja, se agarra o pega a otras personas		

PUNTUACIÓN PONDERADA Y DOMINIOS VITALES (Rabins et al., 1999)

5 Dominios Específicos del ADRQL:

- **1. Interacción social:** Relación con otros y comunicación no verbal.
- **2. Conciencia de sí mismo:** Respuestas emocionales e identidad.
- **3. Sentimientos y estados de ánimo:** Afecto positivo vs agitación.
- **4. Actividades de ocio y disfrute:** Interés en entorno lúdico.
- **5. Reacción al entorno:** Confort ambiental y adaptación.

Puntuación Global (0 a 100%):

- Cada ítem posee un peso factorial validado empíricamente.
- Puntuaciones más altas indican mejor calidad de vida preservada en la demencia.
- Permite guiar planes no farmacológicos y apoyo al cuidador.